

Fallbeskrivning 1 – RA

Anna-Lena är 52 år och arbetar som undersköterska. Hon är tidigare väsentligen frisk men röker. De sista sex månaderna har hon upplevt ökande besvär med värk och svullna leder i händerna. Till en början har svullnaden kommit och gått men sista månaderna har de varit mer eller mindre konstanta. Allra värst är besvären på morgnarna då stelheten varar ca 2 timmar. Värken påverkar nattsömnen och Anna-Lena känner sig trött och sliten. Anna-Lena har också fått sämre matlust och har gått ner ca 2 kilo i vikt under de senaste månaderna. Då Anna-Lenas mamma har ledgångsreumatism är Anna-Lena rädd att hon drabbas av samma sjukdom. Hon söker nu till sin vårdcentralläkare som noterar att Anna-Lena inte kan knyta sina händer och att hon har flertalet svullna leder, bland annat handleder, knogar och inre fingerleder. Läkaren misstänker reumatoid artrit (RA) och skickar Anna-Lena till provtagning. Blodprovet visar en sänka på 45, ett CRP på 28 och förekomst i blodet av anti-citrullinerad peptid antikroppar (ACPA) och positiv reumatoidfaktor (RF).

- 1. Vilka symtom i fallbeskrivningen om Anna-Lena tyder på att hon har drabbats av RA? Redogör också för andra typiska symtom som ofta förekommer vid reumatoid artrit.**
- 2. Vid RA drabbas ledhinnan. Vad är ledhinnan, och förklara vad som sker med den vid RA. Redogör även för de patofysiologiska processer som leder till de symtom som uppstår vid sjukdomen.**
- 3. Beskriv orsaker till RA? Finns det några riskfaktorer för RA hos Anna-Lena?**
- 4. Förklara vad det är för blodprover Anna-Lena tagit och innebörden av hennes provsvar i relation till referensvärden?**
- 5. Hur ställs diagnosen vid RA?**

Anna-Lena informeras om svaret och remitteras till sjukhusets reumatologmottagning pga misstänkt RA. Till dess att hon får tid dit skriver läkaren ut Naproxen att ta två gånger dagligen mot ledbesvären. Läkaren sjukskriver också Anna-Lena då ledbesvären gör att hon i dagsläget inte kan arbeta som undersköterska. Fyra veckor senare kallas Anna-Lena till reumatologmottagning där reumatologläkaren konstaterar att hon är morgonstel, har flera svullna leder i händer och fötter, förhöjd sänka och CRP samt ACPA och positiv reumatoidfaktor (RF) i blodet. Reumatologläkaren fastställer med bakgrund av detta diagnosen RA och skriver ut Metotrexat i upptrappande dos att ta varje måndag. Hon får

även tablett Folacin att ta fredag och lördag samt Prednisolon i nedtrappningsdos.

6. Efter att diagnosen fastställs sätts Anna-Lena in på Metotrexat, Folacin och Prednisolon.

- a. Vad är Metotrexat för läkemedel och hur verkar detta? Vad innebär upptrappande dos? Vilka vanliga biverkningar finns med Metotrexat?**
- b. Vad är Folacin? Varför ordineras Anna- Lena Folacin och varför tas detta läkemedel just på dessa dagar?**

Mottagningssköterskan träffar sedan Anna-Lena som är ledsen och orolig över diagnosbeskedet och sin situation. Till följd av smärta, stelhet och trötthet har hon på senaste tiden inte haft ork att röra på sig som vanligt och stängt in sig mer och mer hemma. Hon har gått ner ytterligare i vikt.

Sjuksköterskan ger information om läkemedelsbehandlingen och berättar om hur vården framöver är upplagd. Anna-Lena är tveksam till föreslagna läkemedel men kan tänka sig att pröva dom. Anna-Lena har många frågor kring vad hon kan göra utöver att ta läkemedlen för att må bättre och undrar över specifik kost och träning som kan vara bra. Sjuksköterskan informerar också under deras samtal att Anna-Lena på grund av Metotrexatbehandling behöver ta prover regelbundet. Tillsammans formulerar Anna-Lena och sjuksköterskan en plan för den fortsatta vården. Inom den närmaste tiden kommer Anna-Lena även att få träffa övriga i det reumatologiska teamet, närmare bestämt fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator och dietist.

7. Vilka möjliga omvårdnadsproblem och behov hittar du i fallbeskrivningen med Anna-Lena?

8. Vilka oberoende omvårdnadsåtgärder kan vara aktuella utifrån Anna-Lenas omvårdnadsproblem?

9. Vad svarar du Anna-Lena gällande hennes frågor om kost och träning?

10. Varför behöver Anna-Lena ta prover regelbundet och vilka är de vanligaste rutinproverna (säkerhetskontrollerna) vid antireumatiska behandlingar?

Vid uppföljning hos sjuksköterska efter 6 veckor mår Anna-Lena bättre. Hon träffar fysioterapeuten 2 gånger i veckan och har också träffat en arbetsterapeut som utformat ett handträningsprogram och provar ut lämpliga hjälpmedel till Anna-Lena. Hon har också varit på ett besök hos kuratorn och dietisten. Vid återbesök hos reumatologläkare efter 3 månader är hon

väsentligen helt besvärsfri. Då upphör också sjukskrivningen och hon återgår till att arbeta heltid, precis som före sjukdomsdebuten. Hon har också kunnat börja träna mer på egen hand och tycker att livet känns lättare. Läkaren diskuterar med henne om vikten att sluta röka och ordnar kontakt med mottagningens rökavvänjningssjuksköterska för stöd till rökstopp. Läkaren informerar också om att blodprovstagningen efter återbesöket successivt tunnas ut till en gång var tredje månad då hon visat sig tåla medicinen väl och inte haft några biverkningar.

11. Varför är det viktigt för Anna-Lena att sluta röka? Svara både specifikt utifrån hennes RA-diagnos men även mer generella vinster av att sluta röka.

Under flera år mår Anna-Lena i stort sett bra. Hon lever ett aktivt liv trots sin diagnos. Medicineringen och behandlingen har god effekt, aptiten kommer tillbaka och hon har återfått sin ursprungliga vikt. Hon börjar nu känna sig oförklarligt trött och har den senaste månaden haft svårigheter att böja sitt högra knä, som nu också sedan en vecka är rött, svullet och värker mest hela tiden. Hon har även värk i vänster knä, och kan inte längre promenera och eller delta i andra fysiska aktiviteter. På grund av smärtan och svårigheten att röra sig har hon även i stor utsträckning varit borta från arbetet. Anna-Lena tar därför kontakt med sin läkare och får komma på ett nytt läkarbesök då man konstaterar att sjukdomen nu gått in i en svårare fas. CRP och SR visar sig åter vara förhöjda. Läkaren ger henne kortisoninjektioner direkt in i de leder som är mest inflammerade. Hen ordinerar dessutom en kombinationsbehandling för Anna-Lena. Den innebär att hon ska fortsätta med metotrexat samt börja med etanercept, ett så kallat biologiskt läkemedel som hon ska ge sig själv som injektion. Innan behandlingen inleds är det viktigt att säkerställa att Anna-Lena inte har tuberkulos med hjälp av ett quantiferontest. Detta visar sig vara negativt, vilket gör att Anna-Lena kan påbörja sin behandling. Först tycker hon tanken på att ge sig själv sprutor är väldigt obehaglig och hon tvivlar på om hon kommer kunna klara av det. Efter en stunds samtal med sjuksköterskan kommer hon ändå fram till att hon vill prova. Hon får först öva att ge injektionen på en attrapp innan hon ger sig själv den första sprutan med läkemedel. Innan hon går hem reviderar hon och sjuksköterskan tillsammans den plan och de mål som Anna-Lena tidigare satt upp. De bestämmer hur och när de ska höras nästa gång för att följa upp den nya medicinen och hur det går med det vardagliga livet med RA. Anna-Lena får också tid hos fysioterapeut och arbetsterapeut för nya bedömningar och stöd för att komma igång med träningen igen.

Fallet om Anna-Lena är hämtat från följande källa och har skrivits om för att passa kursens innehåll:

Mandl, T. & Bala, V. (2022). Reumatiska sjukdomar och osteoporos. I Ekwall, A. & Jansson, A.M. (Red.), *I Omvårdnad & medicin* (2 uppl., s. 425-473). Studentlitteratur

• Fallbeskrivning 2 – Sjögrens syndrom

Emma, 45 år, arbetar som lärare på mellanstadiet. Hon är sambo med Lukas och tillsammans har de tre barn, 14, 10 och 8 år gamla. Hon trivs bra med sitt arbete, men har de senaste månaderna varit otroligt trött och känt sig hängig. Hon har haft det extra stressigt ett tag och tänker att det nog är förklaringen till att hon inte är på topp. Det har varit mycket på arbetet, och privat har yngsta sonen tvingats byta ut en trasslande pacemaker. Han mår nu äntligen bra igen, men Emma är helt slut. Hon känner sig aldrig utsövd, lederna gör ont, munnen är snustorr, ögonen känns grusiga och samlivet med Lukas går på sparlåga. Det känns torrt i underlivet och hon är så trött att hon bara vill sova. Emma tänker att hon kanske kan vara i klimakteriet.

Eftersom Emma inte alls tycks bli bättre beställer hon en tid på vårdcentralen. Där blir hon undersökt av en läkare som ordinerar en del prover. Det visar sig då att Emma har förhöjt SR och CRP. När hon dessutom uppvisar symtom som muntorrhet och torra ögon blir hon remitterad till specialistläkare i reumatologi för utredning. På reumatologmottagningen tas ännu fler prover som visat att hon har en viss typ av speciella autoantikroppar, anti-SSA och anti-SSB. Hon får också göra ett Schirmertest och ett Sialometritest. Efteråt berättar läkaren att dessa undersökningar tyder på Sjögrens syndrom. Hen vill därför göra ytterligare ett test, en spottkörtelbiopsi, för att se om det finns inflammatoriska förändringar i spottkörtlarna. Läkaren berättar också att de speciella autoantikroppar som påvisats hos Emma innebär en ökad risk för att få barn som utvecklar AV-block under graviditeten. Emma berättar då att hennes yngast son fötts med hjärtblock och fått pacemaker kort efter födelsen, men att hon verkligen inte haft någon aning om att det berott på att hon hade dessa autoantikroppar.

- 1. Vilka symtom hittar du i fallbeskrivningen om Emma som tyder på att det är Sjögrens syndrom hon drabbats av?**
- 2. Vid Sjögrens syndrom drabbas kroppens exokrina körtlar, vad är exokrina körtlar och vilken funktion har dom? Förklara också vad som sker med dessa körtlar vid Sjögrens syndrom och vad som händer i kroppen som ger symtomen vid sjukdomen (patofysiologi).**
- 3. Beskriv orsaker till Sjögrens syndrom? Finns det några riskfaktorer för Sjögrens syndrom hos Emma?**
- 4. Förklara vad det är för blodprover Emma tagit?**

5. Emma får genomföra schirmertest, sialometritest och en spottkörtelbiopsi. Vad är detta för undersökningar och vad har de för betydelse för att ställa diagnos?

Efter läkarbesöket träffar Emma sjuksköterskan på mottagningen, de pratar igenom vad Emma just hört och hur det kommer bli framöver.

6. Vilka omvårdnadsproblem hittar du i fallbeskrivningen med Emma?

7. Vilka oberoende omvårdnadsåtgärder kan vara aktuella utifrån Emma omvårdnadsproblem?

Efter en vecka kommer svaret på spottkörtelbiopsin och ett telefonsamtal från läkaren bekräftar diagnosen Sjögrens syndrom. Biopsin visade hög inflammatorisk aktivitet i spottkörtlarna och Emma ordineras hydroxyklorokintabletter.

8. Emma ordineras hydroxyklorokintabletter, vad är detta för typ av läkemedel och varför ordineras Emma detta läkemedel?

Så sakteligen börjar Emma må bättre. Hon är fortfarande torr i mun och ögon, och tycker det är ganska tröttsamt att hålla på med ögondroppar och sugtabletter, men när hon inte använder dem blir ögonen snustorra och munnen som illasmakande öken. Hon kämpar därför på med sina tår- och saliversättningsmedel. Hon är fortfarande ganska trött men samlivet fungerar något bättre vilket Emma känner sig tacksam över.

Fallet om Emma är hämtat från följande källa och har skrivits om för att passa kursens innehåll:

Welin, E. (202). Omvårdnad vid reumatiska sjukdomar. I Stubberud D-G, Gronseth, R & Almås, H (Red.), *I Klinisk omvårdnad 2* (3 uppl., s. 215-235). Liber

Fallbeskrivning 3 – Gikt

Ove är en 62 årig lagerarbetare som väger 104 kg och dricker ca 2 starköl per dag. Han har sedan tidigare högt blodtryck som han medicinerar med Hydroklortiazid. Ove söker vårdcentralen då han föregående natt vaknat med smärtor i ena stortån. Sjuksköterskan som tar emot honom noterar att stortåns grundled är svullen och rodnad. Ove berättar att den gör fruktansvärt ont. Sjuksköterskan kontrollerar CRP som är 70 och misstänker gikt. Ove får en tid hos vårdcentralsläkaren.

- 1. Vilka symtom hittar du i fallbeskrivningen om Ove som tyder på att det är gikt han drabbats av?**
- 2. Förklara också vad som sker i kroppen och ger dessa symtom vid gikt (patofysiologi).**
- 3. Beskriv orsaker till gikt? Finns det några riskfaktorer för gikt hos Ove?**
- 4. Förklara vad det är för blodprov Ove tagit och innebörden av provsvaret i relation till referensvärden?**

På misstanke om gikt vill läkaren bekräfta detta genom att påvisa kristaller i ledvätskan från den inflammerade leden. Han får påbörja behandling med Diklofenak.

- 5. Ove ordineras Diklofenak, vad är detta för typ av läkemedel och varför ordineras Ove detta läkemedel? Beskriv även verkningsmekanismen och biverkningar.**

Ove informeras per telefon om provsvaret som visar förekomst av spetsiga uratkristaller och att diagnosen således är bekräftad. För att minska risken för fler giktanfall byts den vattendrivande medicinen mot annan blodtryckssänkare och han rekommenderas att minska sin alkoholkonsumtion och gå ner i vikt. Läkaren bokar i samråd Ove en tid till en sjuksköterska för ett hälsosamtal om levnadsvanor.

- 6. Hur ställs diagnosen vid gikt?**
- 7. Varför är det viktigt för Ove drar ner på sin alkoholkonsumtion och att gå ner i vikt? Svara både specifikt utifrån hans gikt-diagnos men även mer generella vinster ni känner till.**
- 8. Vad innebär ett hälsosamtal? Vad tänker ni är viktigt att prata om med Ove på detta samtal?**

Fallet om Ove är hämtat från följande källa och har skrivits om för att passa kursens innehåll:

Mandl, T. & Bala, V. (2022). Reumatiska sjukdomar och osteoporos. I Ekwall, A. & Jansson, A.M. (Red.), *I Omvårdnad & medicin* (2 uppl., s. 425-473). Studentlitteratur

Fallbeskrivning 4 – fibromyalgi

Maria är 47 år och har beställt tid hos sin vårdcentralsläkare då hon sedan ett drygt halvår besvärats av smärtor i muskulaturen med varierad lokalisation, dock mest uttalat runt skuldergördeln och på överarmarna, men även i lårmuskulaturen. Hon känner sig stel och öm i hela kroppen, mest uttalat på morgnarna, men stelheten finns med hela dagen, liksom smärtupplevelsen. Hon tycker också att fingrar, händer och fötter känns svullna och att hon känt sig ovanligt trött och energilös. Maria är gift och har två tonårsbarn. Hon arbetar som personalchef i högt uppsatt position inom ett stort försäkringsbolag. Hon har tidigare rökt, men slutade för två år sedan. Hon dricker sig aldrig berusad men ett glas vin till middagen är standard. Maria är tidigare frisk.

Läkarens undersökning av Maria visar att hon har tydlig smärtutlösning över 9 av 18 för fibromyalgi typiska triggerpunkter och ordinerade prover visar följande: hb 124, CRP under 5, trombocyter 350 och leukocyter 4,9. Maria har beskrivit stelhet framförallt på morgonen och att hon upplever svullnad om händer och fötter. Vid undersökning föreligger avsaknad av synoviter i hand-, finger-, fot- eller tāleder och ingen direkt palpationsömhet över lederna vilket talar emot ledsjukdom. Läkaren misstänker ett kroniskt smärttillstånd/fibromyalgi men att utredningen är viktig för att utesluta andra orsaker till Marias långvariga smärttillstånd. Läkaren skriver remiss till fysioterapeut för start av lämplig fysioterapibehandling och ordinerar ytterligare provtagning för fortsatt utredning.

Vid återbesök 4 veckor senare berättar Maria att hon varit på besök hos fysioterapeut vid fyra tillfällen. Hon tycker hon upplevt övergående smärtlindring under behandlingen hos fysioterapeuten men att den varit övergående. Maria vill dock gärna ha fortsatt kontakt med fysioterapeut. Svar på de beställda laboratorieanalyserna har kommit och samtliga analyser visar resultat inom normalområdet. Läkaren gör ett nytt led- och muskelstatus och Maria anger nu stark ömhet vid palpation över 11 av de 18 punkterna, vilket stödjer diagnosen kroniskt smärtsyndrom/fibromyalgi. Läkaren bokar in ett uppföljande besök hos sjuksköterska.

- 1. Vilka symtom hittar du i fallbeskrivningen om Maria som tyder på att det är fibromyalgi hon drabbats av? Vilka andra typiska symtom finns vid fibromyalgi?**
- 2. Förklara vad som händer i kroppen vid sjukdomen (patofysiologi) som ger symtomen vid sjukdomen.**
- 3. Beskriv orsaker till fibromyalgi? Finns det några riskfaktorer för fibromyalgi hos Maria?**

- 4. Förklara vad det är för blodprover Maria tagit och innebörden av hennes provsvar i relation till referensvärden?**
- 5. Hur ställer läkaren diagnosen vid fibromyalgi?**
- 6. Finns det någon behandling som ni tror läkaren kommer ordinera?**
- 7. Vilka omvårdnadsproblem hittar du i fallbeskrivningen med Maria?**
- 8. Vilka oberoende omvårdnadsåtgärder kan vara aktuella utifrån Maria omvårdnadsproblem?**

Ett tips om du vill fördjupa dig lite (12.45 min in):

<https://reumatiker.se/blogg/langvarig-smarta-krav-en-behandlingsplan>

Fallet om Maria är hämtat från följande källa och har skrivits om för att passa kursens innehåll:

Turesson, C., Jacobsson, J & Engström-Laurent, A. (2017). Led- och systemsjukdomar. I Lindgren, S., Engström-Laurent, A., Karason, K. & Tiensuu Janson, E. (red.), *Medicin*. (2 uppl., s 521-568). Studentlitteratur

Fallbeskrivning 5 – Parkinson (PS)

Anna är 58 år och arbetar på bank. Hon är gift och har en son i 25-årsåldern och en dotter som går sista året på gymnasiet. Senaste halvåret har hon haft besvär med höger axel och det var svårt att få skidåkningen att fungera under senaste fjällresan. Efter ett besök på vårdcentralen för att följa upp axelbesvären remitteras hon till neurolog eftersom det tillkommit problem med handstil och distriktsläkaren noterade kugghjulsfenomenet i handleden. Neurologen som hon träffade frågade om många saker och det framkom att hon i några år haft sämre luktsinne, att hon börjat prata i sömnen det senaste året och att magen är lite trög. Anna berättar att hon upplevt att hon sista tiden haft svårare att få ihop livet, lite som att hon tappar tråden och helt enkelt svårt att hålla koll på allt. Efter undersökning får hon det för henne överraskande beskedet att det kan handla om Parkinsons sjukdom. Anna blir förvånad. Hon trodde att PS var när man skakade i hand/arm, och hon har inte alls upplevt något sådant. Hon får översiktlig information om sjukdomen, erbjuds läkemedelsbehandling med Madopark och träff bokas med fysioterapeut. Nytt besök för uppföljning bokas hos läkare och sjuksköterska om två veckor. Neurologen säger att Annas make gärna får följa med nästa gång om han vill för att få mer information om Parkinson.

- 1. Vilka symtom på Parkinson hittar du i fallbeskrivningen om Anna? Vilka andra typiska symtom finns vid Parkinson?**
- 2. Förklara vad som sker i kroppen vid Parkinson? (patofysiologi)**
- 3. Beskriv orsaker till Parkinson? Finns det några riskfaktorer för Parkinson hos Anna?**
- 4. Anna ordineras Madopark, vad är detta för typ av läkemedel och hur verkar det? Redogör även för vanliga biverkningar och vilken information Anna behöver få kring läkemedlet för att behandlingen ska fungera så bra som möjligt?**

Vid besöket hos sjuksköterskan 2 veckor senare har Anna sin make med sig. Både upplevs väldigt chockade över beskedet. Anna berättar att hon funderat mycket på sjukdomen och att hon ibland kände tvivel kring om diagnosen verkligen var rätt och en oro för hur det skulle gå för henne och familjen i framtiden. Anna berättar att hon kommit igång med träning hos fysioterapeut och att hon märkt att det tillsammans med läkemedelsbehandlingen haft god effekt på flera av hennes besvär vilket stödjer diagnosen PS. Sjuksköterskan svarar på Anna och hennes makes frågor, ger upprepad information om Parkinson samt hennes läkemedelsbehandling. Egenvård och hälsofrämjande aktiviteter diskuteras och Anna vill fortsätta att gå till fysioterapeuten. Anna

och hennes make erbjuds att påbörja mottagningens Parkinsonskola vilket de båda är positiva till.

5. Hur ställer läkaren Annas diagnos?

Anna och hennes make påbörjar Parkinsonskola och har Anna har kontinuerlig kontakt med sin ansvariga sjuksköterska. Livet flyter på. Skidåkning går fint nästa säsong och det njuter Anna av. Anna som inte hade tremor initialt utvecklar efter en tid det i ena handen. På jobbet märker hon av att det inte fungerar lika bra som tidigare. Det verkar som att arbetet kräver mycket mer kraft nu och Anna känner sig ofta ganska utmattad när arbetsveckan är slut. Efter en hektisk period inför bokslut behöver hon sjukskriva sig en period. För att kartlägga hennes förutsättningar görs en neuropsykologisk utredning där man identifierar svårigheter med exekutiva funktioner och processhastighet. Det framkommer också en förhöjd uttrötthet. Anna får kontakt med arbetsterapeut och tränar sig på strategier för att hantera fatigue och planera aktiviteter med utrymme för återhämtning. Neurologen skriver intyg för förebyggande sjukskrivning för att hon ska kunna träna regelbundet. Med hjälp av det stöd som Anna har fått av teamet i kontakt med sin arbetsgivare har hon hittat en bra balans mellan arbetet och att ha tid för att ta hand om sig själv, träna och återhämta krafterna. Under de sista två åren innan pension hade hon 25 % sjukersättning, vilket fungerade bra.

Som nybliven pensionär märker hon att vardagssysslor tar längre tid, särskilt på morgonen. Ofta blir hon trött på dagen, men tänker att det hänger ihop med att hon nyligen gått i pension. I samband med träningspass noterar fysioterapeuten att Annas skakningar tilltagit och att hon ser "off" ut halvtimmen innan dostid. Det rapporteras till läkaren och vid följande återbesök väcks frågan om dosglapp och fluktuationer och behovet att justera hennes läkemedel. I samtalet med ansvarig läkare och sjuksköterska framkommer det att Anna upplever ökade problem med förstoppning och att tröttheten känns ohållbar.

6. Vilka omvårdnadsproblem hittar du i fallbeskrivningen med Anna?

7. Vilka oberoende omvårdnadsåtgärder kan vara aktuella utifrån Annas omvårdnadsproblem?

8. Vad innebär dosglapp och fluktuationer?

<https://www.parkinsonförbundet.se/om-parkinsons-sjukdom/symtom/dosglapp/>

Fallet om Anna är hämtat från följande källa och har skrivits om för att passa kursens innehåll:

Hellqvist, C., Nilsson, M H., Renck Ljunggren, A., Ozanne, A & Zelano, J. (2023). Parkinsons sjukdom och atypisk parkinsonism. I Ozanne, A. & Zelano, J. (red.), *Teamarbete i neurologisk vård*. (1 uppl., s. 195-240). Studentlitteratur.

Fallbeskrivning 6 – MS

Malin är 23 år gammal och studerar till sjuksköterska. Hon har arbetat inom servicenäringen och rest lite efter gymnasiet men har nu påbörjat sina universitetsstudier. Malin har inga sjukdomar sedan tidigare. Hon har rökt sedan hon var 14 år och hon har växt upp med passiv rökning då båda hennes föräldrar är rökare. Hon fick körtelfeber vid 15 års ålder efter att ha träffat sin första kärlek. Hennes moster och mormor har MS men förutom det finns inga sjukdomar i familjen.

Malin vaknade en dag med en domning av vänster fot. Hon tänker först att det berodde på att hon sovit djupt efter en kväll ute med vännerna, men istället för att försvinna började domningen att sprida sig uppöver benet under dagen. Malin har haft likande symtom tidigare men då har domningen släppt. På kvällen kände hon en påverkan upp till lumsken. När hon berättade det för sina föräldrar och sin bror lugnade de henne med att det nog berodde på stress eller kommande ryggskott. Malin hade svårt att sova under natten och när hon tidigt påföljande morgon skulle gå på toaletten märkte hon att benet inte bar och hon haltade fram. Föräldrarna blir då oroliga och kör henne till akuten på universitetssjukhuset i staden där de bor. Övertygade om att det rör sig om en hjärntumör kräver de omedelbar hjälp och de blir mycket frustrerade när Malin får vänta flera timmar. Känslpåverkan hade nu nått navelnivå. Läkaren gör en neurologisk undersökning och Malin får genomföra en CT som är utan patologiska fynd. Malin läggs in för fortsatt utredning och får under kvällen svårigheter att tömma blåsan.

Påföljande dag göra en MR av hjärna och helrygg med gadoliniumkontrast som visar åtta misstänkta demyeliniserande förändringar i hjärnan och en i ryggmärgen. Två av lesionerna i hjärnan och den i ryggmärgen laddar kontrast, som tecken på aktiv inflammation. Malin får genomgå en lumbalpunktion som visar lätta tecken på inflammation med lätt ökning av antalet vita blodkroppar i ryggmärgsvätskan. Malin ordinerar SoluMedrol 1 g per dag i tre dagar, och går därefter hem och symtomen lättar efter några dagar. En remiss skickas till MS-mottagningen med ett bokat återbesök efter två veckor. Under väntetiden hade alla provsvar kommit och visade förekomst av produktion av oligoklonala IgG-band i ryggmärgsvätska och MS-diagnos fastställs. Malin sätts in på sjukdomsmodifierande behandling. Malin är mycket chockad och ledsen över beskedet.

- 1. Vilka symtom hittar du i fallbeskrivningen om Malin som tyder på att det är MS hon drabbats av? Vilka andra typiska symtom finns vid MS?**
- 2. MS är en sjukdom som drabbar myelinet på nerver i det centrala nervsystemet, CNS. Förklara vad myelin och CNS är och beskriv**

vad som vad som händer i kroppen vid MS och hur det kan förklara symtomen som uppstår? (patofysiologi)

- 3. Beskriv orsaker till MS? Finns det några riskfaktorer för MS hos Malin?**
- 4. Förklara vilka undersökningar läkaren har använt sig för att fastställa diagnosen och vad som krävs för att kunna ställa diagnosen MS?**
- 5. Malin ordineras primärt SoluMedrol, vad är detta för typ av läkemedel och varför ordineras Malin detta läkemedel?**
- 6. Förklara vad sjukdomsmodifierande behandling innebär?**

Fem år senare sätts Malin upp för ett extra återbesök på MS-mottagningen efter att hon kontaktat MS-sjuksköterskan och meddelat att hon blivit gravid. Det var inte helt planerat men hon ser framemot barnet. Hon är bekymrad över sin MS-behandling och om barnet riskerar att ärva sjukdomen. Hon vill sätta ut sin behandling för att skydda barnet men vill samtidigt inte riskera att få ett skov som kan påverka henne som gravid och ny mamma. Hon har inte haft några skov men återhämtade sig aldrig helt från det första skovet och upplever lätta domningar i vänsterfoten vid träning och tendens att få blåsträngningar om hon väntar för länge mellan toalettbesök. Malin har även problem med fatigue. Hon arbetar som sjuksköterska på en öppenvårdsmottagning sedan tre år tillbaka och har haft svårt när hon måste bearbetad många intryck under dagen. När hon kommer hem från arbetet sover hon nästan alltid och måste ofta ställ in aktiviteter på grund av tröttheten. Graviditeten har nu väckt frågor kring om hur hon ska klara av att vara förälder.

- 7. Vilka omvårdnadsproblem hittar du i fallbeskrivningen med Malin?**

- 8. Vilka oberoende omvårdnadsåtgärder kan vara aktuella utifrån Malins omvårdnadsproblem?**

Fallet om Malin är hämtat från följande källa och har skrivits om för att passa kursens innehåll:

Axelsson, M., Ågren, J., Kristersson, E & Zelano, J. (2023). Multipel Skleros. I Ozanne, A. & Zelano, J. (red.), *Teamarbete i neurologisk vård*. (1 uppl., s. 161-193).

Studentlitteratur.

Fallbeskrivning 7 – Epilepsi

Karl, 40 år, förs till akutmottagningen efter att hans fru vaknat av att han en sen lördagskväll skrikit i tv-soffan, varit stel i kroppen och skakat. Han vaknade först under ambulansfärden till sjukhus, där han genomgick datortomografi av hjärnan och observerades över natten med kontinuerlig hjärtövervakning som inte visade något avvikande. Vid utskrivningen fick Karl information om att han inte fick köra bil på sex månader och att remiss skulle skrivas till neurolog. Vid Karls uppföljande läkarbesök till neurolog framkom inte något ytterligare. Vittnesbeskrivning inhämtas per telefon från hans fru som bekräftar att det sannolikt varit ett epileptiskt anfall. Karls mamma har berättat att hans morbror förmodligen hade haft epilepsi. EEG och MR genomförs utan anmärkning.

Karl har märkt att hans fru är orolig. Han känner sig frustrerad över att känna sig påpassad, men han har samtidigt själv också varit orolig för ytterligare anfall. Karl får information om att endast hälften av personer som får ett första epileptiskt anfall får epilepsi och att det andra anfallet ofta inträffar under de första månaderna upp till två år, varefter risken minskar markant. Han får också information om vilka högriskaktiviteter han bör avstå. Karl får tid till ett informationsbesök tillsammans med sin fru hos epilepsisköterska.

Karl får efter tre månader ett nytt epileptiskt anfall. Den här gången sitter hans fru i soffan med honom och ser hur han först vrider huvudet åt höger och blir stel i höger arm som böjs, varefter han rätar ut benen och båda armarna och blir stel. Efter någon minut har anfallet kommit och han vaknar denna gång innan ambulansens ankomst. På akutmottagningen gör man en undersökning och konstaterar att han inte skadat sig och är återställd. Han behöver inte läggas in för observation och remiss skickas åter till neurologen.

Hos neurologen en månad senare träffar Karl samma läkare som efter sitt första anfall. Han får information om att det nu finns grund för epilepsidiagnos och föreslås läkemedelsbehandling för att minska risken för nya anfall. Det vill han ha och olika alternativ och presenteras och diskuteras. Karl väljer i samråd med ansvarig läkare behandling med Lamotrigin och får ett schema för hur dosen ska stegvis ska stegras. Han får information om körkort och högriskaktiviteter. Han har några funderingar om två arbetsresor i närtid och funderingar om vad epilepsin kommer att innebära för jobbet. Han får information om att det mest sannolika är att han blir anfallsfri av sitt första eller andra läkemedel, även om det inte finns några garantier.

På det efterföljande sjuksköterskebesöket diskuteras först upptrappningen av lamotrigin, som frånsatt lätt huvudvärk har gått bra. Karl tar upp att han bekymrar sig över hur barnen hanterar att han fått epilepsi och accepterar sjuksköterskans erbjudande om ett informationssamtal inriktad mot barn.

- 1. Vilka symtom på epilepsi hittar du i fallbeskrivningen om Karl?**
- 2. Anfallsbeskrivningen för tankarna till att Karls typ av anfall är fokala anfall. Vad innebär det och vad skiljer fokala anfall från generaliserade anfall?**
- 3. Förklara vad som händer i kroppen vid epilepsi? (patofysiologi)**
- 4. Beskriv orsaker till Epilepsi?**
- 5. Karl genomför EEG och MR. Vad är detta för typ av undersökningar och varför görs dessa på Karls?**
- 6. Hur ställer läkaren Karls diagnos?**
- 7. Karl ges information om vilka högriskaktiviteter han bör avstå, vad innefattar denna information?**
- 8. Karl ordineras lamotrigin, vad är detta för typ av läkemedel och varför ordineras Karl detta läkemedel? Beskriv även verkningsmekanismen och biverkningar.**

Efter tre månader kommer Karl på uppföljande läkarbesök. Läget är gott. Han har inga biverkningar eller tecken på nedstämdhet och har inte haft några anfall. När tolv månader förflutit sedan det första anfallet kommer ett meddelande om önskemål om receptförnyelse. Sedan sker ingen kontakt före nästa läkarbesök, som av väntelisteskal blir först 18 månader efter det första. Karl mår bra. Han kommer ihåg sitt Lamotrigin. Han badar inte längre ensam men uppger att han i övrigt inte upplever att hans epilepsi påverkar livsföringen så mycket. Han har berättat om diagnosen för sin chef och sin närmsta kollega på kontoret, men ingen annan.

Fallet om Karl är hämtat från följande källa och har skrivits om för att passa kursens innehåll:

Gustafsson, L., Ljunggren, S., Ozanne, A & Zelano, J. (2023). Epilepsi. I Ozanne, A. & Zelano, J. (red.), *Teamarbete i neurologisk vård*. (1 uppl., s. 115-156). Studentlitteratur.

Fallbeskrivning 8 – Epilepsi

På samma mottagning vårdas Anna, nu 25 år, som fick epilepsi i tonåren och efter några besvärliga år med läkemedelsjusteringar utan att uppnå anfallsfrihet remitterades hon för avancerad utredning till det specialiserade regioncentret för epilepsivård. Där genomgick hon en lång utredning med både EEG, MR-röntgen av hjärnan, neuropsykologisk utredning och video-EEG med inopererade elektroder i hjärnan innan man kunde konstatera att hennes epilepsi hade sitt ursprung i vänster temporallob. Hon erbjöds och tackade ja

till en temporallobsektomi, ett avlägsnande av strukturer i de strukturer som befunnits orsaka hennes anfall. Hon fick veta innan operationen att chansen till anfallsfrihet var omkring 65 % och att den största risken med behandlingen var att hon skulle få sämre inlärnings- och minnesförmågor. Anna blev efter operationen anfallsfri men upplevde det första året hjärntrötthet och sämre minne.

Med facit i hand tre år senare är Anna mycket nöjd med beslutet, anfallsfriheten har lett till en helt annan trygghet i vardagen, hon behöver inte längre hela tiden oroa sig för anfall. Hon har kunnat sänka dosen av sina epilepsiläkemedel så att hon inte längre känner sig trött och seg i huvudet dem. Minnet är sämre och det hon lider mest av är de sociala konsekvenserna det fört mig sig: att hon inte med självklarhet minns konversationer hon haft och att hon glömmer viktiga saker. Hennes strategier handlar mycket om att vara öppen och ärlig med sina minnesbekymmer så att hon inte ska uppfattas som ointresserad eller nonchalant mot sin omgivning. Förklarar hon varför hon inte minns upplever hon att de flesta förstår. På arbetet fungerar det bra, hon har rutiner som gör att risken att glömma saker är väldigt liten. Sammanfattningsvis tycker hon att livskvaliteten är högre nu, som anfallsfri, men hade operationen inte gjort henne anfallsfri och hon ändå hade haft minnesbekymmer efteråt, då vet hon inte hur hon hade resonerat. Fortfarande vågar hon inte lita helt på att anfällen inte kommer tillbaka men har inte längre samma oro över vardagen som hon hade tidigare. Det skönaste tycker hon är att slippa den oförutsägbarhet som epilepsin förde med sig, nu kan hon planera utan att behöva ta hänsyn till risken att få anfall.

- 1. Anna har till skillnad från Karl inte fått anfallsfrihet med farmakologisk behandling och genomgått kirurgi. Vilka kriterier finns för att kunna vara aktuell för kirurgi vid epilepsi?**
- 2. Hur påverkas Anna av att leva med epilepsi och hur har det förändrats före respektive efter operationen?**

Fallet om Anna är hämtat från följande källa och har skrivits om för att passa kursens innehåll:

Gustafsson, L., Ljunggren, S., Ozanne, A & Zelano, J. (2023). Epilepsi. I Ozanne, A. & Zelano, J. (red.), *Teamarbete i neurologisk vård*. (1 uppl., s. 115-156). Studentlitteratur.